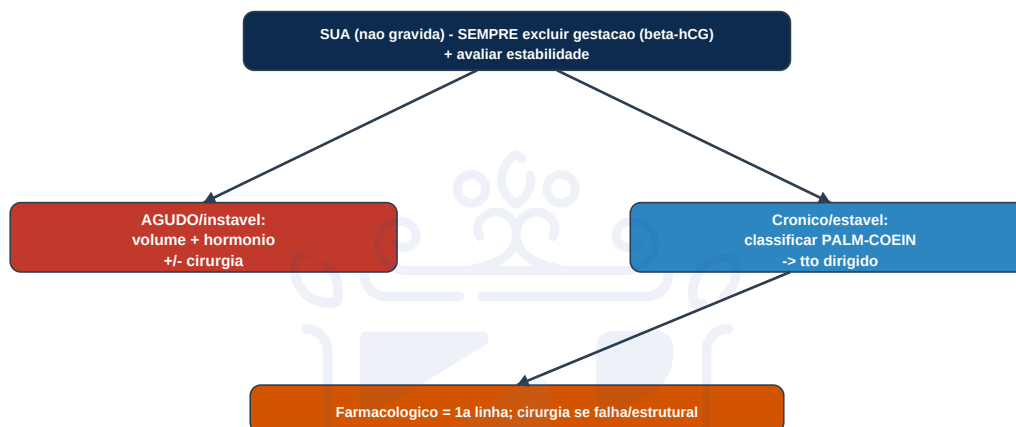


SANGRAMENTO UTERINO ANORMAL — PALM-COEIN

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

SUA — EXCLUIR GESTAÇÃO, ESTABILIZAR, CLASSIFICAR



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Sangramento agudo ou crônico do corpo uterino, anormal na regularidade, volume, frequência ou duração, em mulher NÃO grávida
- SEMPRE excluir gestação (beta-hCG) — é o primeiro passo
- Classificação etiológica: PALM-COEIN
- PALM (estruturais): Pólipo, Adenomiose, Leiomioma, Malignidade | COEIN (não estruturais): Coagulopatia, Ovulatória, Endometrial, Iatrogênica, Não classificada

ANAMNESE E RED FLAGS

AValiação

- Menarca e DUM; início das alterações; ritmo, frequência, volume e duração
- História sexual/reprodutiva; contracepção; último Papanicolau; medicações de uso contínuo
- História familiar: neoplasia, endocrinopatia, coagulopatia (suspeitar de coagulopatia em SUA desde a menarca)
- RED FLAGS: instabilidade hemodinâmica, sangramento volumoso, anemia sintomática
- Suspeita de malignidade (pós-menopausa, fatores de risco) -> investigar endométrio

INVESTIGAÇÃO

EXAMES

- Exame especular: descartar lesões vaginais/cervicais como fonte do sangramento
- BETA-HCG (excluir gestação); hemograma + coagulograma (avaliar anemia/coagulopatia)
- Endócrino conforme suspeita: TSH, FSH, LH, prolactina, androgênios
- USG transvaginal (estrutura, espessamento endometrial, miomas/pólipos)
- Histeroscopia: avalia lesões intracavitárias não esclarecidas ao USG + permite biópsia

SUA AGUDO — ESTABILIZAR E ESTANCAR

Rx SANGRAMENTO ACENTUADO

Restabelecer equilíbrio hemodinâmico: reposição volêmica + considerar hemotransfusão; abordagem cirúrgica se necessário

Estrogênio EV (não disponível no Brasil) — alternativas hormonais orais:

Etinilestradiol 35 mcg + Noretisterona 1 mg: 1 cp 3x/dia por 1 semana, depois 1 cp/dia por mais 3 semanas

Medroxiprogesterona 20 mg 3x/dia por 1 semana, depois 1x/dia por 3 semanas

Ácido tranexâmico 1 g 8/8h por 5 dias (se contraindicação ao estrogênio)

TRATAMENTO POR ETIOLOGIA (crônico)

Causa	Tratamento
Não estrutural (hormonal)	1a linha: combinado estro-progestativo; progestagênio isolado; SIU de levonorgestrel (atrofia endometrial)
Não estrutural (não hormonal)	Ácido tranexâmico 1g 3-4x/dia por 3-4 dias (reduz ~50%); AINE (ác. mefenâmico) reduz 25-50% e a dismenorreia
Pólipo	Polipectomia histeroscópica
Mioma (submucoso é o mais associado)	Farmacológico; cirurgia se sem resposta
Adenomiose	Frequentemente histerectomia (sangramento + dismenorreia)

TRATAMENTO CIRÚRGICO

QUANDO

- Indicado na FALHA do tratamento clínico ou em causa estrutural específica
- Ablação endometrial: menos invasiva que histerectomia; para pacientes SEM lesão estrutural e sem desejo reprodutivo
- Histerectomia: tratamento de exceção (definitivo)
- Antifibrinolítico contraindicado se história de tromboembolismo ou insuficiência renal
- AINE evitado em paciente com doença ulcerosa péptica

CHECKLIST NO PS

NÃO ESQUECER

- ☐ Excluir gestação (beta-hCG) SEMPRE
- ☐ Avaliar estabilidade hemodinâmica e anemia (hemograma)
- ☐ Especular para descartar fonte vaginal/cervical
- ☐ Agudo: estabilizar + hormônio/ácido tranexâmico; crônico: classificar PALM-COEIN
- ☐ Pós-menopausa ou suspeita de malignidade -> investigar endométrio (USG/biópsia/histeroscopia)

MODELO DE ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Mulher ____ anos, NÃO grávida (beta-hCG negativo), com SUA ____ (agudo/crônico); volume ____; Hb ____.
- USG transvaginal: ____ (mioma/pólipo/espessamento); classificação PALM-COEIN: ____.
- Conduta: estabilização + hormonal/ác. tranexâmico; encaminhamento para histeroscopia/cirurgia se indicado.
- Solicito avaliação ginecológica (estrutural/falha clínica) / internação se instabilidade ou anemia grave.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Mulher de 35 anos com sangramento uterino aumentado. Qual o PRIMEIRO passo na avaliação?

- A) Histerectomia
- B) Excluir gestação com beta-hCG
- C) Iniciar ácido tranexâmico sem investigação
- D) Solicitar ressonância de pelve
- E) Ablação endometrial

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

O que significa a classificação PALM-COEIN do sangramento uterino anormal?

- A) Estágios de uma neoplasia
- B) Causas estruturais (PALM: pólio, adenomiose, leiomioma, malignidade) e não estruturais (COEIN)
- C) Grau de dilatação cervical
- D) Critérios de transfusão
- E) Fases do ciclo menstrual

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual medicação não hormonal reduz o volume do sangramento menstrual (até ~50%)?

- A) Ácido tranexâmico
- B) Omeprazol
- C) Metformina
- D) Furosemida
- E) Levotiroxina

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual tipo de mioma está mais associado ao sangramento uterino anormal?

- A) Subseroso
- B) Submucoso
- C) Intramural pequeno
- D) Pediculado seroso
- E) Calcificado

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual é a primeira linha de tratamento do SUA de causa não estrutural?

- A) Histerectomia
- B) Tratamento farmacológico (hormonal e/ou antifibrinolítico/AINE)
- C) Ablação endometrial imediata
- D) Embolização uterina
- E) Apenas observação

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

O primeiro passo na avaliação do SUA é SEMPRE excluir gestação com beta-hCG, pois muda completamente a abordagem (sangramento da gestação tem outro manejo).

QUESTÃO 2 → Resposta: B

PALM-COEIN classifica as causas: PALM = estruturais (Pólipo, Adeniose, Leiomioma, Malignidade) e COEIN = não estruturais (Coagulopatia, Ovulatória, Endometrial, Iatrogênica, Não classificada).

QUESTÃO 3 → Resposta: A

O ácido tranexâmico (antifibrinolítico) reduz o volume do sangramento menstrual em até ~50%. Contraindicado se história de tromboembolismo ou insuficiência renal.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Os miomas submucosos são os mais associados ao sangramento uterino anormal, por distorcerem a cavidade endometrial. Subserosos costumam causar sintomas compressivos, não sangramento.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A primeira linha do SUA não estrutural é o tratamento farmacológico (hormonal — combinado, progestagênio, SIU-LNG — e/ou não hormonal — ácido tranexâmico/AINE). A cirurgia fica para falha ou causa estrutural.

SM24
Suporte ao Plantão Médico